

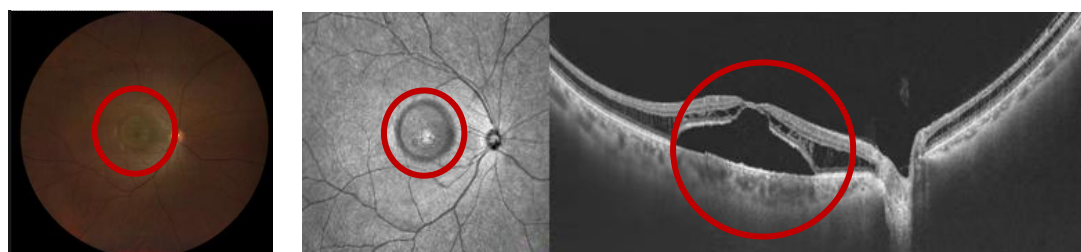
1、oct 片子的切面图是否需要根据病灶来生成对应区域？

Q1:需要根据眼底相上的病灶生成对应区域。下面我举几个相关例子：

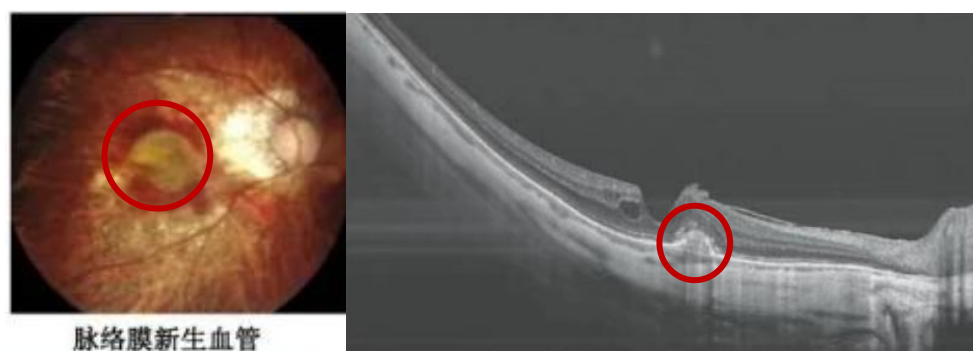
(1) 病理性近视-黄斑裂孔眼底~oct 对应关系



(2) 病理性近视-黄斑劈裂眼底~oct 对应关系



(3) 脉络膜新生血管~oct 对应关系



2、比如：出现黄斑区，需要生成黄斑区的切面。

Q2:oct 只扫描黄斑区，只聚焦于黄斑区的病变，至于视盘，以及视网膜其他区域的病变，可以不作生成。

3、比如：出现弥漫性萎缩，需要以视乳头为基准生成对应的切面。

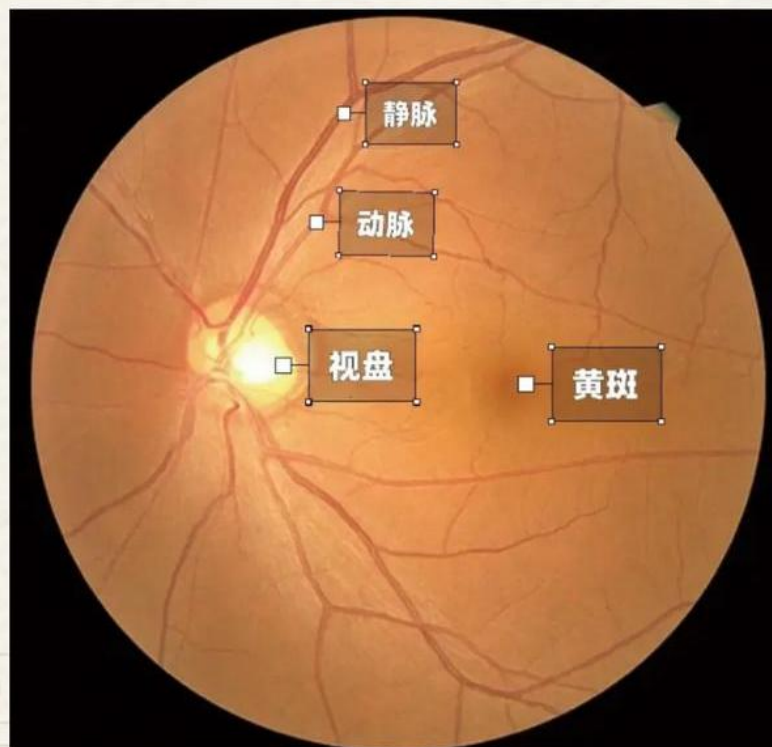
Q3:不需要生成视乳头的切面，视乳头区域病变仅靠眼底相就可以判断。

4、比如：出现斑片性萎缩，需要以斑片区域为基准生成对应的切面

Q4:不需要生成斑片性萎缩区域的切面，视乳头区域病变仅靠眼底相就可以判断。

5、黄斑区是眼底肌变薄对吧？

Q5:黄斑区和眼底肌肉没有特别联系，黄斑区是视网膜上的一个结构区域，是行使视功能最重要的区域。下面我列出了一个解剖结构图：



正常眼底

正常眼底的是：视盘圆，边界清，
色泽淡红， $C/D=0.3$

视网膜血管：走向正常， $A:V=2:3$

动脉静脉管径均匀

黄斑、视网膜：黄斑中心凹反光明显

视网膜可见湿丝绸反射未见异常

提示：双眼底未见明显异常

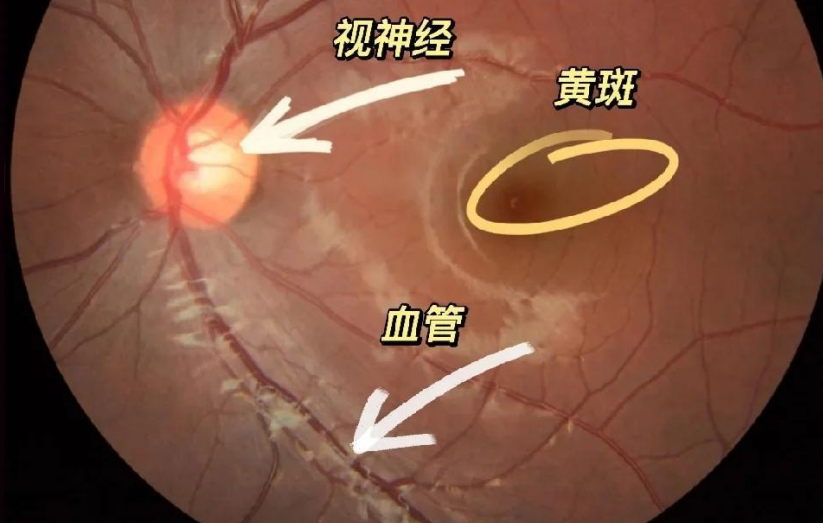
6、萎缩、豹纹状眼底等眼底肌厚度有什么变化？

Q6:萎缩、豹纹状眼底仅靠眼底相就可以辨别，不涉及 oct 扫描厚度变化，仅靠视觉就可以感知。



L 45°

完美眼底状况



R 45°

高度近视豹纹状

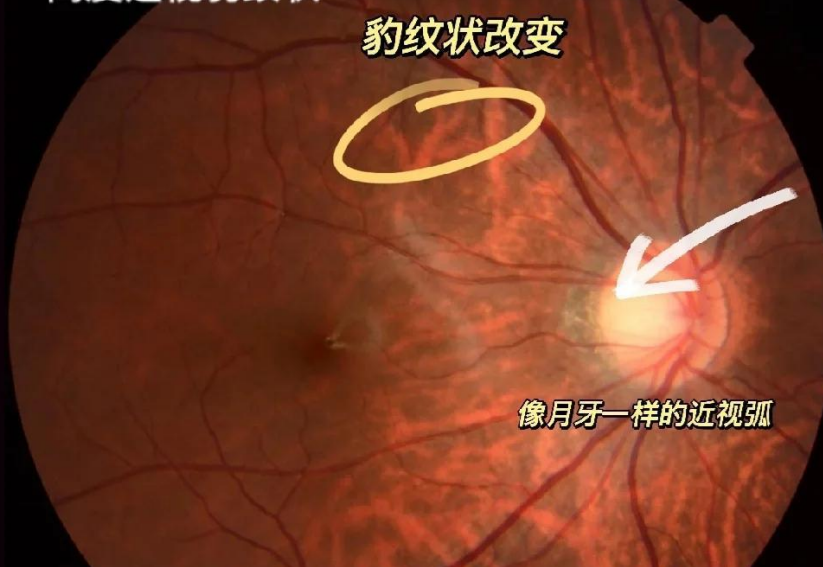




图 1



图 2

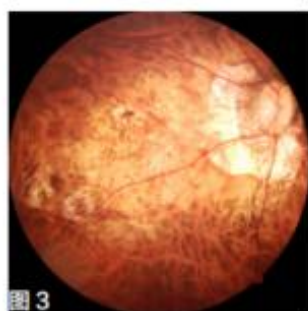


图 3

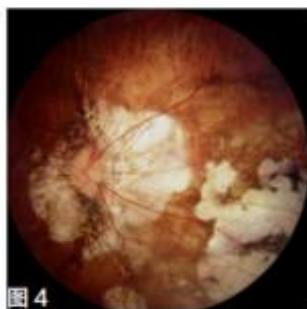


图 4

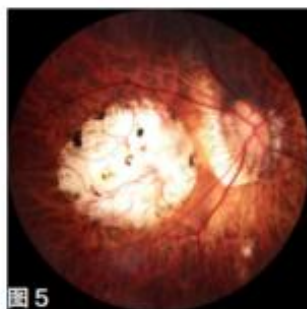


图 5

图 1 无眼底病变 (Normal) 的高度近视眼底图像；图 2 豹纹状眼底 (C1 级) 的高度近视眼底图像；图 3 弥漫性萎缩 (C2 级) 的高度近视眼底图像；图 4 斑片状萎缩 (C3 级) 的高度近视眼底图像；图 5 黄斑萎缩 (C4 级) 的高度近视眼底图像